

ТЗ с одним правильным ответом

Патоморфоз туберкулеза —это {

~уменьшение заболеваемости населения туберкулезом

=изменение клинического течения и морфологических проявлений
инфекционного процесса

~уменьшение смертности от туберкулеза

~снижение инфицированности населения туберкулезом

~увеличение числа случаев инфильтративного туберкулеза

}

Причиной патоморфоза туберкулеза, происшедшего за последние годы,
явилось {

~применение профилактических прививок

~раннее выявление туберкулеза

~химиотерапия туберкулеза

~химиопрофилактика туберкулеза

=уменьшение резервуара туберкулезной

инфекции

}

Ложное впечатление об изменении в течении туберкулеза и его
морфологических реакций может появиться вследствие {

~применения профилактических прививок

~проведения новых лечебных мероприятий

~изменения условий жизни населения

=применения новых диагностических методов

}

К проявлениям патоморфоза первичных форм туберкулеза у детей можно

отнести учащение выявления {
~первичного комплекса
~туморозного бронхоаденита
~инфильтративного бронхоаденита
="малых" форм бронхоаденита
~плеврита
}

К проявлениям ложного патоморфоза туберкулеза можно отнести учащение
выявления в 50-60-х годах {
=очаговой формы туберкулеза
~инфильтративной формы туберкулеза
~диссеминированной формы туберкулеза
~деструктивного туберкулеза легких
}

В настоящее время у больных с вновь выявленным туберкулезом легких
чаще всего обнаруживается {
~очаговая форма туберкулеза
=инфильтративная форма туберкулеза
~диссеминированная форма туберкулеза
~туберкулема легкого
}

Жалобы больного туберкулезом органов дыхания {

~слишком субъективны и не отражают истинной клинической картины заболевания

~только частично отражают истинную клинику и симптоматику заболевания

=объективно и в достаточной мере отражают истинную клинику заболевания

~специфичны для этого заболевания и позволяют по ним провести дифференциальную диагностику с другой легочной патологией

}

Условия жизни больного{

~не оказывают существенного влияния на риск заболеть туберкулезом и на последующее течение инфекционного процесса

=оказывают существенное влияние на риск заболеть туберкулезом и на последующее течение инфекционного процесса

~оказывают только некоторое влияние на риск заболеть туберкулезом и совсем мало влияют на его течение

~оказывает существенное влияние на риск заболеть туберкулезом и совсем мало влияют на его течение

}

Клиническая симптоматика начала заболевания и его течение до выявления туберкулеза{

=может существенно повлиять на формирование диагноза клинической формы туберкулеза после завершения обследования больного

~обычно мало влияет на концепцию о клинико-рентгенологической форме легочного туберкулеза

~не сказывается на оценке клинико-рентгенологической формы легочного туберкулеза

~обычно мало влияет на формирование диагноза клинической формы туберкулеза

}

Формы туберкулеза легких, протекающие с массивным размножением микобактерии туберкулеза в тканях и выраженной экссудативной реакцией в очаге (очагах) поражения выявляются с помощью {

=клинических методов исследования

~флюорографических методов исследования

~лабораторных методов исследования

~инструментальных методов исследования

}

Формы туберкулеза, протекающие с малым накоплением микобактерии туберкулеза в очаге (очагах) поражения и характеризующиеся

преимущественно продуктивной воспалительной реакцией выявляются обычно {

~клиническим методом исследования

=флюорографическим методом исследования

~лабораторным методом исследования

~инструментальных методов исследования

}

Больные легочным туберкулезом с бактериовыделением предъявляют жалобы на недомогание, лихорадку, кашель с мокротой {

~в 20-30% случаев

~в 30-50% случаев

=в 80-90% случаев

~ 10-15% случаев

}

Туберкулезу органов дыхания более свойственно {

~острое начало заболевания

=подострое начало заболевания

~бессимптомное начало заболевания

~ молниеносное начало заболевания

}

При туберкулезе органов дыхания между данными клинических методов исследования и изменениями, обнаруженными на рентгенограмме, как правило{

~имеется полное соответствие

~нет полного соответствия, клиническая симптоматика более богата

=нет полного соответствия, рентгенологические изменения более обширны

~ частичное соответствия

}

Участок поражения легкого туберкулезом определяется с помощью перкуссии при его субплевральном расположении и размере{

~от 2-3 см

=от 4-5 см

~от 7-8 см

~от 1-2 см

}

Хрипы в легких при дыхании возникают{

~в респироне легкого и респираторных бронхиолах

~в терминальных бронхиолах

=в бронхах

~в строме легкого

}

Мелкопузырчатые влажные хрипы в легких возникают обычно при поражении{

~мелких бронхов

~мембранных бронхов

=бронхов среднего калибра (5-8-го порядка)

~крупных (1-4-го порядка) бронхов

}

Клинически малосимптомно и без изменений, выявляемых с помощью физических методов исследования, протекает{

=очаговый туберкулез легких

~инфильтративным туберкулез легких

~диссеминированный туберкулез

~фиброзно-кавернозный туберкулез

~цирротический туберкулез

}

Клинической симптоматикой, как правило, сопровождается{

~очаговый туберкулез легких

~туберкулема легких

=инфильтративный туберкулез легких

~ диссеминированный туберкулез

}

Обычно протекает инанпероцептно и выявляется только при массовой флюорографии населения{

=туберкулема легких

~инфильтративная форма туберкулеза легких

~цирротическая форма туберкулеза легких

~ очаговая форма туберкулеза

}

Выраженность патологических сдвигов в клиническом анализе крови и в ряде биохимических показателей крови и ее сыворотки определяется всеми следующими показателями, кроме{

~распространенности поражения легких

~наличия и выраженности экссудативных и казеозных изменений

=длительности туберкулезного процесса

~особенностей реакции костного мозга и некоторых других

}

Наиболее распространенные методы выявления микобактерии туберкулеза включают все перечисленные ниже, кроме{

~бактериоскопического

~культурального

~метода обогащения

=биологического

}

Основными объектами исследования на микобактерии туберкулеза служат все перечисленные, кроме{

~мокроты

~промывных вод бронхов

~пунктата из закрытых полостей

~мочи

=крови

}

Основными качественными и количественными методами определения микобактерии туберкулеза являются все перечисленные ниже, кроме{

~метода Циля – Нильсена

~люминисцентного метода

~метода Гаффки – Стинкена

=иммунологического метода

}

К основным (стандартным) методам рентгенологического исследования

при заболеваниях органов дыхания относятся все перечисленные, кроме{

=флюорографии и рентгеноскопии

~рентгенографии в прямой проекции

~рентгенографии в боковой проекции

~томографии в прямой проекции

~томографии в боковой проекции

}

К дополнительным методам рентгенологического метода исследования при

заболеваниях органов дыхания относятся все перечисленные, кроме{

=флюорографии и рентгеноскопии

~бронхографии

~ангиографии

~рентгенографии и томографии

~компьютерной томографии

}

Рентгенологическое исследование при заболеваниях органов дыхания

следует начинать {

~ с флюорографии в прямой и боковой проекциях

~с рентгеноскопии в различных проекциях

=с обзорной рентгенографии в прямой и боковой проекциях

~с томографии легких в прямой и боковой проекциях

~с томографии средостения в прямой и боковой проекциях

}

При оценке фазы дыхания, в которой выполнена прямая обзорная рентгенограмма грудной клетки, следует учитывать {

=положение правого купола диафрагмы

~положение левого купола диафрагмы

~положение правого и левого куполов диафрагмы

~степень прозрачности легочных полей

~характер дуг средостения

}

Боковая рентгенограмма грудной клетки позволяет получить всю

дополнительную информацию, кроме {

~состояния отделов грудной клетки, не получивших отображения в прямой проекции

~локализации патологического процесса относительно долей и сегментов легких

~распространенности патологического процесса в легких

=состояния легочного рисунка

}

При патологических процессах в легких, средостении и (или) корнях в первую очередь следует применять томографию {

=с продольным направлением размазывания

~с поперечным направлением размазывания

~бронхотомографию

~компьютерную томографию

}

Во фтизиатрической практике чаще других применяют рентгенофункциональную пробу{

~Вальсальвы

~Мюллера

=Вальсальвы - Мюллера

~Соколова

}

К недостаткам бронхографии, проведенной под эндотрахеальным наркозом, следует отнести{

~большое число противопоказаний к исследованию

~большое число осложнений во время исследования

~технические трудности

=невозможность ранней диагностики функциональных нарушений в бронхиальном дереве

}

Важным преимуществом бронхографии, выполненной под местной анестезией, является{

~меньшее число противопоказаний к исследованию

~меньшее число осложнений во время исследования

~отсутствие технических трудностей

~невозможность сочетать это исследование с трахеобронхоскопией

=возможность раннего выявления функциональных нарушений в бронхах

}

Сцинтиграфия легких с изотопами позволяет уточнить{

~состояние мелких сосудов легких

~состояние крупных сосудов легких

~состояние мелких и крупных сосудов легких

=состояние капиллярного кровотока легких

}

Полиморфизм очаговых теней в легких определяют все перечисленные ниже признаки, кроме{

~разной их величины

~разного характера их контура

~разной их формы

~разной их интенсивности

=разной их локализации

}

Туберкулез бронха, выявленный во время бронхоскопии, протекает клинически малосимптомно{

~в 5-7% случаев

~в 20-30% случаев

=в 50% случаев

~ 10-15% случаев

}

Лечебная бронхоскопия у больных туберкулезом показана{

~при инфильтративном туберкулезе бронха без выраженного стеноза его просвета

=при язвенном туберкулезе стенки долевого бронха с разрастанием грануляции, стенозирующих его просвет

~при локальном катаральном эндобронхите

~при разлитом гипертрофическом эндобронхите

}

При трансбронхиальной щипцовой биопсии берутся на исследование {

~кусочки слизистой бронха

~кусочки стенки бронха со слизистой

оболочки и хрящевой тканью

=участки паренхимы легкого

}

Материал биопсии, полученный с помощью аспирационной катетеризационной биопсии, подвергается {

~гистологическому и цитологическому исследованию

~цитологическому и биохимическому исследованию

~биохимическому и морфологическому исследованию

~бактериологическому и биохимическому исследованию

=цитологическому и бактериологическому исследованию

}

В лаважной жидкости, полученной из легкого здорового человека, преобладают {

~лимфоциты

~нейтрофилы

=альвеолярные макрофаги

~фагоциты

}

В лаважной жидкости больного туберкулезом преобладают {

=лимфоциты

~эпителиоидные и гигантские клетки

~нейтрофилы

~альвеолярные макрофаги

}

Биопсию лимфатических узлов прескаленного пространства предложил {

~Вирхов

=Даниэльс

~Классен

~ Кох

}

Трансторакальную биопсию легкого иглой следует проводить {

=при шаровидных затемнениях

~при пневмониеподобных затемнениях

~при очаговых затемнениях

~при тяжистом характере затемнения в интерстиции легкого

}

Больного с шаровидным образованием в легком, природу которого уточнить в ходе обследования не удалось, решили назначить на операцию – это {

~ резекция легкого

~открытая биопсия легкого

=диагностическая торакотомия

~торакопластика

}

Больного с бессимптомно протекающим диссеминированным поражением в легком с помощью клинико-рентгенологического и лабораторных методов исследования уточнить природу изменений не удалось, следует провести: {

~краевую резекцию легкого
~диагностическую торакотомию
=открытую биопсию легкого
~ резекцию легкого
}

Так называемый "первичный туберкулезный комплекс" —это{

~первичный туберкулез, характеризующийся наличием туберкулезных изменений в легких

~туберкулез, характеризующийся наличием инфильтрата в легких, воспалительной дорожки к корню легкого и регионарным лимфаденитом
=туберкулез первичного периода, характеризующийся наличием очага или инфильтрата в легком, воспалительной дорожки и регионарным лимфаденитом

~ первичный туберкулез, характеризующийся наличием воспалительной дорожки.
}

Так называемый "первичный туберкулезный комплекс" чаще наблюдается на территориях

=с высокой заболеваемостью туберкулезом
~со средним уровнем заболеваемости туберкулезом
~с низким уровнем заболеваемости туберкулезом
~с любым уровнем заболеваемости туберкулезом
}

Для первичного туберкулезного комплекса наиболее характерны морфологические изменения в виде всего перечисленного, кроме {
~экссудативных реакций
=продуктивных реакций
~казеозного некроза в легких
~казеозного некроза в лимфатических узлах корня легкого
}

Для неосложненного первичного комплекса наиболее характерен {
~сухой кашель
~влажный кашель
~боли в груди
=синдром интоксикации
}

Первичный туберкулезный комплекс необходимо дифференцировать {
~с раком легкого с метастазами в лимфатические узлы легкого
=с острой пневмонией
~с пороком развития легкого
~с эозинофильным инфильтратом
}

При лечении больных первичным туберкулезным комплексом необходимо учитывать все следующие особенности химиотерапии этих больных, кроме {
~выбора препарата с учетом возможной первичной лекарственной устойчивости МВТ
~подбора химиопрепаратов с учетом наличия казеозного некроза

~удлинения сроков химиотерапии с учетом замедленного заживления туберкулеза в лимфатических узлах

=учета того, что у больного молодого возраста ранее никогда не применялись химиопрепараты

}

Кальцинаты в лимфатических узлах при заживлении первичного туберкулезного комплекса{

~формируются всегда

~не формируются

~формируются в порядке исключения

=формируются при выраженном казеозном некрозе

}

Формирование кальцинатов в лимфатическом узле при заживлении первичного туберкулезного комплекса зависит{

~от характера проведенного лечения

~от величины лимфатического узла

=от выраженности казеозного некроза в

лимфатическом узле

~от наличия или отсутствия осложнений процесса

}

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов —это{

~туберкулез органов дыхания с обязательным поражением внутригрудных лимфатических узлов

~туберкулез первичного периода с поражением внутригрудных лимфатических узлов

~туберкулез с локализацией во внутригрудных лимфатических узлах

=заболевание туберкулезом первичного или вторичного периода инфекционного процесса, основной локализацией которого является поражение внутригрудных лимфатических узлов

}

При неосложненной инфильтративной форме туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов наблюдаются все следующие рентгенологические признаки, за исключением {

=тень корня смещена, наружный контур ее четкий, бугристый

~тень корня расширена

~структура тени корня смазана

~тень корня деформирована

~наружный контур тени нечеткий

}

Инфильтративную форму туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов отличает от опухолевой следующий рентгенологический признак {

~тень корня расположена обычно

~тень корня расширена

~структура тени корня смазана

~тень корня деформирована

=наружный контур тени нечеткий

}

Кальцинаты во внутригрудных лимфатических узлах указывают на то, что {

~туберкулезный процесс потерял активность

~туберкулезный процесс находится в фазе кальцинации

~туберкулез перешел в хроническую стадию

=необходимо провести уточнение

активности туберкулезных изменений

}

Диссеминированный туберкулез легких -это{

~гематогенный туберкулез с преимущественным поражением легких

~распространенное двустороннее поражение легких

=распространенное, чаще двустороннее, тотальное или ограниченное поражение легких с преобладанием очаговых или интерстициальных изменений в легких гематогенного, лимфогенного или бронхогенного происхождения

}

Пути распространения туберкулезной инфекции при диссеминированном туберкулезе легких могут быть все перечисленные, кроме{

~гематогенного

~лимфогенного

~бронхогенного

=капельно-аэрогенного

}

Частота диссеминированного туберкулеза легких среди вновь выявленных больных составляет{

~4-6%

=10-12%

~ 15-20%

~25-30%

}

Частота диссеминированного туберкулеза легких среди диспансерных контингентов I и II групп учета составляет{

~4-6%

=10-12%

~15-20%

~25-30%

}

Диссеминированный туберкулез легких может протекать по всем перечисленным клиническим вариантам, кроме{

~острого

~подострого

~хронического

=рецидивирующего

}

При гематогенно-диссеминированной форме туберкулеза легких в первую очередь поражаются{

=межуточная ткань

~паренхима

~бронхи

~плевра

}

Наиболее частыми локализациями патологического процесса при остром милиарном туберкулезе являются{

=легкие и печень

~легкие и селезенка

~печень и селезенка

~селезенка и почки

~почки и оболочки головного мозга

}

При остром милиарном туберкулезе очаговые тени в легких при рентгенологическом исследовании обнаруживаются{

~у всех больных

=у 75-80% больных

~у 50% больных

~менее чем у 50% больных

}

Размер очагов в легких при остром милиарном туберкулезе {

=мелкий

~средний

~крупный

~разный

}

Клинические признаки, позволяющие заподозрить у больного острый милиарный туберкулез – это {

~лихорадка, одышка, сильный сухой кашель, рассеянные сухие хрипы в легких

=лихорадка, постепенно нарастающая одышка при отсутствии в легких физикальной симптоматики, тахикардия

~лихорадка, кашель с мокротой, рассеянные сухие и локальные влажные хрипы в легких

}

Размер очагов в легких при подостром гематогенно-диссеминированном туберкулезе легких преимущественно {

~мелкий

=средний

~крупный

~разный

}

Начальные проявления заболевания при бронхогенном диссеминированном туберкулезе легких бывают {

~выраженные

~стертые

~бессимптомные

=разнообразные

}

Очаговый туберкулез легких - это {

~туберкулезный процесс ограниченной протяженности

~туберкулезный процесс, характеризующийся стертой клинической картиной при выявлении и торпидном течении

~туберкулезный процесс, характеризующийся наличием очаговых изменений в легких

=туберкулезный процесс, характеризующийся стертой клинической картиной, торпидным течением, скудным бактериовыделением, а также наличием одиночных или множественных очаговых изменений в легких разного генеза и давности с локализацией в одном или обоих легких в пределах одного-двух сегментов

}

Частота очагового туберкулеза легких среди впервые выявленных больных составляет {

~10-20%

=30-40%

~50-60%

~70-80%

К недостаткам бронхографии, проведенной под эндотрахеальным наркозом, следует отнести {

~большое число противопоказаний к исследованию

~большое число осложнений во время исследования

~технические трудности

=невозможность ранней диагностики функциональных нарушений в бронхиальном дереве

}

Важным преимуществом бронхографии, выполненной под местной анестезией, является {

~меньшее число противопоказаний к исследованию

~меньшее число осложнений во время исследования

~отсутствие технических трудностей

~невозможность сочетать это исследование с трахеобронхоскопией

=возможность раннего выявления функциональных нарушений в бронхах

}

Сцинтиграфия легких с изотопами позволяет уточнить {

~состояние мелких сосудов легких

~состояние крупных сосудов легких

~состояние мелких и крупных сосудов легких

=состояние капиллярного кровотока легких

}

Полиморфизм очаговых теней в легких определяют все перечисленные ниже

признаки, кроме {

~разной их величины

~разного характера их контура

~разной их формы

~разной их интенсивности

=разной их локализации

}

Туберкулез бронха, выявленный во время бронхоскопии, протекает клинически малосимптомно{

~в 5-7% случаев

~в 20-30% случаев

=в 50% случаев

~ 10-15% случаев

}

Лечебная бронхоскопия у больных туберкулезом показана{

~при инфильтративном туберкулезе бронха без выраженного стеноза его просвета

=при язвенном туберкулезе стенки долевого бронха с разрастанием грануляции, стенозирующих его просвет

~при локальном катаральном эндобронхите

~при разлитом гипертрофическом эндобронхите

}

При трансбронхиальной щипцовой биопсии берутся на исследование{

~кусочки слизистой бронха

~кусочки стенки бронха со слизистой

оболочки и хрящевой тканью

=участки паренхимы легкого

}

Материал биопсии, полученный с помощью аспирационной катетеризационной биопсии, подвергается{

~гистологическому и цитологическому исследованию

~цитологическому и биохимическому исследованию

~биохимическому и морфологическому исследованию

~бактериологическому и биохимическому исследованию
=цитологическому и бактериологическому исследованию
}

Для первичного туберкулезного комплекса наиболее характерны
морфологические изменения в виде всего перечисленного, кроме {
~экссудативных реакций
=продуктивных реакций
~казеозного некроза в легких
~казеозного некроза в лимфатических узлах корня легкого
}

Для неосложненного первичного комплекса наиболее характерен {
~сухой кашель
~влажный кашель
~боли в груди
=синдром интоксикации
}

Первичный туберкулезный комплекс необходимо дифференцировать {
~с раком легкого с метастазами в лимфатические узлы легкого
=с острой пневмонией
~с пороком развития легкого
~с эозинофильным инфильтратом
}

При лечении больных первичным туберкулезным комплексом необходимо
учитывать все следующие особенности химиотерапии этих больных,
кроме {

~выбора препарата с учетом возможной первичной лекарственной устойчивости МВТ

~подбора химиопрепаратов с учетом наличия казеозного некроза

~удлинения сроков химиотерапии с учетом замедленного заживления туберкулеза в лимфатических узлах

=учета того, что у больного молодого возраста ранее никогда не применялись химиопрепараты

}

Кальцинаты в лимфатических узлах при заживлении первичного туберкулезного комплекса{

~формируются всегда

~не формируются

~формируются в порядке исключения

=формируются при выраженном казеозном некрозе

}

Формирование кальцинатов в лимфатическом узле при заживлении первичного туберкулезного комплекса зависит{

~от характера проведенного лечения

~от величины лимфатического узла

=от выраженности казеозного некроза в

лимфатическом узле

~от наличия или отсутствия осложнений процесса

}

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов —это{

~туберкулез органов дыхания с обязательным поражением внутригрудных лимфатических узлов

~туберкулез первичного периода с поражением внутригрудных лимфатических узлов

~туберкулез с локализацией во внутригрудных лимфатических узлах

=заболевание туберкулезом первичного или вторичного периода инфекционного процесса, основной локализацией которого является поражение внутригрудных лимфатических узлов

}

При неосложненной инфильтративной форме туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов наблюдаются все следующие рентгенологические признаки, за исключением {

=тень корня смещена, наружный контур ее четкий, бугристый

~тень корня расширена

~структура тени корня смазана

~тень корня деформирована

~наружный контур тени нечеткий

}

Инфильтративную форму туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов отличает от туморозной следующий рентгенологический признак {

~тень корня расположена обычно

~тень корня расширена

~структура тени корня смазана

~тень корня деформирована

=наружный контур тени нечеткий

}

Кальцинаты во внутригрудных лимфатических узлах указывают на то, что {

~ туберкулезный процесс потерял активность

~ туберкулезный процесс находится в фазе кальцинации

~ туберкулез перешел в хроническую стадию

= необходимо провести уточнение активности туберкулезных изменений

}

90

ТЗ с несколько правильными ответами

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов требует проведения

дифференциальной диагностики {

~%33.33333% с неспецифическим лимфаденитом

~%33.33333% с лимфогранулематозом

~%33.33333% с саркоидозом

~%-100% с первичным туберкулезным комплексом

}

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов может осложниться {

~%25% туберкулезом бронхов и бронхолегочным поражением

~%25% ателектазом

~%25% диссеминацией

~%25% плевритом

~%-100% распадом легочной ткани

}

Бронхоскопия у больных туберкулезом показана {

~%25% при всех формах легочного туберкулеза, протекающих с деструкцией и бактериовыделением

~%25% при предоперационном обследовании больных

~%25% при туберкулезных плевритах и туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов

~%25% при бактериовыделении из очага неясной локализации

~ %-100% после резекции доли легкого

}

Прямая томография корней легких и средостения позволяет получить информацию {

~ %33.33333% о состоянии внутригрудных лимфоузлов

~ %33.33333% о состоянии просвета трахеи и крупных бронхов

~ %33.33333% о состоянии крупных сосудов

~ %-100% о состоянии бронхов б-го сегмента и средней доли

Гемограмма у больных с впервые выявленным очаговым туберкулезом легких чаще характеризуется всем указанным ниже, кроме {

~ %50% выраженных патологических сдвигов и резко ускоренной СОЭ

~ %-100% умеренных патологических сдвигов и незначительной ускоренной СОЭ

~ %-100% отсутствия патологических сдвигов и нормальной СОЭ

~ %50% повышение нейтрофилов и ускоренной СОЭ

}

При диагностике острого милиарного туберкулеза необходимы данные {

~ %33.33333% клиническая симптоматика

~ %33.33333% данные рентгенологического исследования

~ %33.33333% данные лабораторного исследования

~ %-100% данные ультразвукового исследования

}

Клинические признаки, позволяющие заподозрить у больного острый милиарный туберкулез – это {

~%50% лихорадка,

~%50% постепенно нарастающая одышка при отсутствии в легких физикальной симптоматики,

~%-100% рассеянные сухие и локальные влажные хрипы в легких

~%-100% брадикардия

}

При подостром гематогенно-диссеминированном туберкулезе легких могут иметь место {

~%33.33333% обильное бактериовыделение

~%33.33333% скудное бактериовыделение

~%33.33333% отсутствие микобактерий в мокроте

~%-100% влажные хрипы

}

Для хронического гематогенно-диссеминированного туберкулеза легких при его выявлении характерны следующие начальные проявления {

~%33.33333% острые

~%33.33333% подострые

~%33.33333% малосимптомные

~%-100% быстротекущие }